

시험 관련 코멘트



목 통증/허리 통증은 과거 나뉘어 있던 ‘목 통증’과 ‘허리 통증’이 합쳐진 항목입니다. 병력 청취와 신체 진찰 항목은 비슷한 면이 있지만, 감별 진단 목록이 완전 다르기 때문에 환자의 주소를 듣고 나누어 생각해야 합니다. 두 항목 모두 신체 진찰과 교육 사항이 많으므로 병력 청취를 짧은 시간안에 효율적으로 진행하는 것이 중요합니다.

목 통증의 경우 통증의 원인에 따라 신경학적 이상과(추간판 탈출, 척추관협착증, 경추신경근병, 경추척수병 등) 신경 외 원인인 근골격 원인(경추염좌, 경추증, 채찍질 손상, 근막통증증후군 등), 기타 (감염, 종양, 류마티스 질환)으로 감별합니다.

허리 통증의 경우 통증의 원인에 따라 신경학적 이상과(척추관협착증, 추간판 탈출, 마미증후군) 신경 외 원인인 근골격 원인(요추염좌, 근육통 등), 기타 (감염, 종양, 류마티스 질환, 연관통)으로 감별합니다.

병력 청취 시 통증의 양상과 강도를 확인하며, 다른 부위에 통증은 또 없는지, 방사통 여부를 확인해야 합니다. 또한 이러한 통증이 어떤 상황에서 악화되고, 완화되는지 요인을 질문하는 것이 중요합니다. 골절 및 외상, 수술, 복용 중인 약물 과거력과 과거 골다공증 검사 여부를 물어보아야 합니다. 그 외 목/허리 통증에 따라 감별 질환에 따라 동반될 수 있는 증상들을 물어야 하므로 병력 청취를 5분 내에 끝내기에 빠듯할 수 있습니다.

신체 진찰의 경우 환자가 불편해하지 않도록 목/허리 진찰을 조심스럽게 해야 하며, 베드에 가서 테스트 해야 하는 것들도 있기에 시간이 빠듯할 수 있습니다. 베드에 바로 눕히는 것과 옆드려서 진행해야 하는 신체 진찰(시진, 촉진 등)이 다르므로 이를 주의해야 합니다. 목, 허리 통증 둘다 신경학적 이상 여부를 확인하기 위해 각각 상지와 하지의 감각, 근력, DTR(Biceps, Triceps/ 무릎, 발목) 검사를 반드시 시행해야 합니다.

목 통증의 경우 통증 부위의 시진/촉진(압통점 여부 확인)과 목의 ROM 평가는 기본적으로 반드시 시행해야 하며, Spurling's test, Lhermitte sign 등 대표적인 검사법의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않으니 필히 익혀둡시다. 또한 DTR 평가 시 SP가 연기해주지 않으니 해머로 제대로 쳐서 정말로 유발시켜야만 관찰할 수 있습니다. 평소에 친구들끼리 꼭 연습해 두어야 합니다.

허리 통증의 경우 통증 부위의 시진/촉진, 운동 범위(ROM) 확인 외에도 하지직거상검사(SLR)와 Patrick test를 반드시 양측 모두 시행하고, 강직성 척추염에서는 Schober test가 추가로 필요할 수 있습니다.

환자 교육에서 신경학적 증상이 악화되는 환자가 아니면 물리 치료, 진통제, 보조기 착용 등 보존적 치료를 먼저 진행하고, 통증이 호전되지 않을 시 수술이 필요할 수 있음을 설명해야 합니다. 허리 통증의 경우 가장 흔한 원인은 요추염좌입니다. 무거운 것을 들거나 빠듯한 병력이 있으면 요추염좌를 의심하고, 2주 정도면 괜찮아진다고 안심을 시키는 동시에 무리한 활동을 제한하고 진통제, 온찜질 등으로 통증을 줄여주어야 합니다. 젊은 남성, 허리와 엉치쪽 통증을 호소하고, 조조강직이 오래 지속되며, 움직이면 통증이 오히려 완화되는 경우 강직성 척추염을 의심해야 하며, 포도막염이 동반될 수 있어 안과 검사가 추가로 필요할 수 있음을 설명해야 합니다.

근무 환경에서의 자세가 질환을 악화시킬 수 있으므로 이에 대한 교정 교육이 필요합니다. 무리한 운동은 삼가는 대신 주기적인 가벼운 스트레칭 및 마사지 등이 도움이 될 수 있으므로 이에 대한 교육이 필요하겠습니다. 목, 허리 통증 모두 갑작스럽게 신경학적 이상인 배변, 배뇨 이상 및 감각/근력 저하가 나타난다면 응급 상황이므로 바로 병원에 내원해야 한다고 교육이 필요하겠습니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

목 통증(Neck pain)

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
목 통증	경추간판탈출증★ (cervical disc herniation)	[병력] 목-팔-손가락까지 방사되는 통증과 저린감, 목 뒤로 젖히면 악화 [검진] Spurling test(+)	[검사] C-spine X-ray, C-spine CT/MRI [치료] 침상 안정, 보조기 착용, 진통제
	경추염좌★ (cervical sprain)	[병력] 뒷목 하부 양측에 둔하면서 쑤시는 듯한 통증, 움직이면 악화, 쉬면 완화, 방사통 X	[검사] C-spine X-ray, C-spine CT/MRI [치료] 경추 보조기, 침상 안정, 스트레칭, 진통제
	채찍질 손상 (whiplash injury)	[병력] 교통 사고 후 목 통증, 두통, 어깨 통증, 구역, 구토, 어지럼, 방사통	[검사] C-spine X-ray, C-spine CT/MRI [치료] 경추 보조기, 침상 안정, 진통제
	근막통증 증후군★ (myofascial pain syndrome)	[병력] 목이 빠근하면서 뒤통수가 당긴다, 가장 흔한 원인, 활동성 유발점에 의해 자율신경 증상(땀나고 털이 곧추섬), 아픈 부위 명확, 단단한 띠 형태	[검사] 임상 증상으로 판단 [치료] 마사지, 소염진통제, 온열 치료, 활동성 근막 유발점에 비늘을 삽입하여 파괴

목 통증	척추관협착증 (spinal stenosis)	[병력] 50세 이상, 서서히 악화됨, 목 및 어깨, 양팔신경근을 따라 나타나는 통증	[검사] C-spine X-ray, C-spine CT/MRI [치료] 침상 안정, NSAID, 경추 보조기
	류마티스 관절염 (rheumatoid arthritis)	[병력] 아침에 뻣뻣, 다른 부위에도 통증	[검사] C-spine X-ray, 혈중 류마티스 인자, anti-CCP, ESR, CRP [치료] NSAID, Glucocorticoid, Methotrexate
	척추 종양 (spinal tumor)	[병력] 체중 감소, 이전에 암 진단받은 병력(폐암, 유방암, 전립선암 등), 배뇨장애 등 여러 이상	[검사] C-spine X-ray, C-spine MRI [치료] 수술, 항암화학요법, 방사선 치료
	수막염 (meningitis)	[병력] 발열, 감기 증상 [검진] 수막 자극 징후 양성	[검사] Spinal tapping, C-spine MRI, Brain MRI, CSF, 뇌 CT/MRI [치료] 항생제, Dexamethasone
	삼차신경통 (trigeminal neuralgia)	[병력] 얼굴이 주로 찌르는 듯이 더 아픈 통증이 갑작스럽게 발생	[검사] Brain MRI [치료] 카바마제핀(carbamazepine), 수술
	전방 구조물 (종양)	[병력] 체중 감소, 목소리 변화, 발음 힘들, 연하곤란	[검사] Neck CT [치료] 수술

허리 통증(Low back pain)

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
허리 통증	요추염좌★ (lumbar sprain)	[병력] 운동, 무거운 짐, 허리근육 통증 [검진] 요추부 운동 제한, 압통점 존재, 신경학적 검사 정상	[검사] L-spine X-ray [치료] 침상 안정, 물리 치료, 요추 보조기
	요추간판 탈출증★ (lumbar disc herniation)	[병력] 요통, 편측 하지 통증, 저린감 [검진] 편측 SLRT(+), 근력 약화, 감각 이상, 건반사 감소	[검사] L-spine X-ray, L-spine CT/MRI [치료] 침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술

허리 통증	척추관협착증★ (spinal stenosis)	[병력] 요통, 하지 통증, 오래 걷기 힘들고 쉬어야 함, 허리 젖히면 악화, 앉아서 쉬거나 누우면 경감 [검진] 하지 운동 및 감각검사 대개 정상, 허리 extension 제한	[검사] L-spine X-ray, L-spine CT/MRI [치료] 침상 안정, 물리 치료, NSAID, 필요 시 수술
	척추 종양★ (spinal tumor)	[병력] 이전 암 병력, 체중 감소, 야간 통증 [검진] 하지 감각 이상, 근력 감소	[검사] L-spine X-ray, L-spine CT/MRI [치료] 방사선 치료, 항암 치료, 수술
	마미증후군 (cauda equina syndrome)	[병력] 요실금, 변실금 [검진] 양하지 근력 저하, 심부건 반사 저하, 회음부, 항문 주변 감각 마비	[검사] L-spine X-ray, L-spine CT/MRI [치료] 응급 수술로 완전히 감압
	강직척추염★ (ankylosing spondylitis)	[병력] 20~30대 젊은 남자, 아침에 허리 뻣뻣하고 통증, 운동-완화, 휴식-악화, UC 동반 [검진] Schober test(+), Patrick test 시 반대측 뒤편 통증(+)	[검사] Lumbar X-ray, HLA B27, ESR, CRP [치료] NSAID, 재활 및 운동 치료, Infliximab
	요추압박골절 (compression fracture)	[병력] 골다공증, 넘어짐, 요통, 요추부 운동 제한 [검진] 신경학적 이상 가능	[검사] L-spine X-ray, L-spine CT/MRI [치료] 요추보조기, NSAID, Opioid, 골다공증 치료, 수술
	골관절염 (osteoarthritis)	[병력] Crepitus 조조강직 <30분, 50세 이상 [검진] ROM 감소	[치료] NSAID, 재활 및 운동 치료, 생활 습관 개선
	반달연골 파열	[병력] 외상력	-
	내측 측부 인대 손상	-	[치료] 휴식, NSAIDs, 얼음찜질, 부목 고정, 수술

목 통증

통증이 시작된 당시 상황이나 통증이 유발된 이유에 대해 자세히 설명?
칼로 찌르듯이? 전기가 통하듯이? 둔하고 뻣뻣하게? 유발 요인? 완화 요인?

Weakness? Paresthesia?

체중 감소?

신경학적 이상

추간판탈출
척추관협착
척추종양

신경 외 원인

외상? 교통사고?
장자리?

골관절/연조직

골절/탈구
류마티스 관절염
척추 감염

목뼈 뻣 / 긴장
근막통증증후군
채찍질 손상
연조직 감염

손/목류? 조강직?

류마티스

류마티스 관절염

열? 몸살?
머리나 얼굴 통증?

연관통

수막염
뇌신경통

허리 통증

Weakness / Sciatica / Claudication
Urinary / Defecation

신경학적 이상

척수

Spinal stenosis
척추분리
척추전방전위

종양
Meningioma
Bone / Cartilage
tumors
Lymphoma

말초신경

추간판탈출
마미증후군

기타 원인

골관절/연조직

뼈
골절(외상, 압박,
척추분리)
척추전방전위
척추측만증

연조직
요추 염좌
근육통

감염
Osteomyelitis
Spinal abscess

종양
Bone metastasis
원발암

자가면역
강직성 척추염
류마티스 관절염

기타
골관절염

류마티스

연관통

복부대동맥류
신장
신우신염
결석
Perinephric
abscess

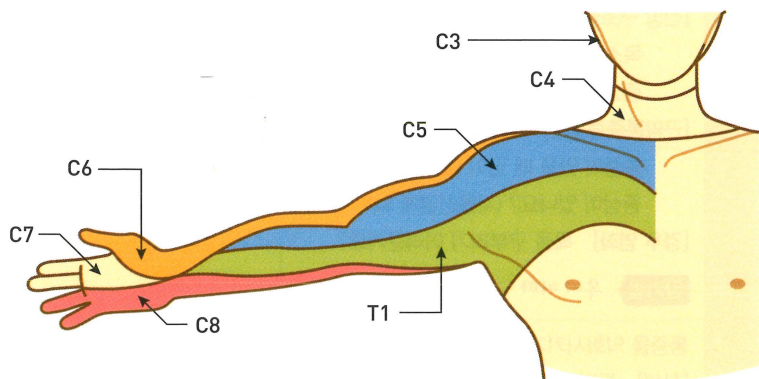
소화 계통
췌장염
담낭염
담석증
위궤양천공

비뇨생식
자궁내막증
PID
전립선염

STEP 1 병력 청취

	목 통증(Neck pain)	허리 통증(Low back pain)
O	언제부터 목/허리가 아팠나요?/갑자기 or 서서히? 특별히 어떤 상황에서 통증이 시작되었나요? [목] 자동차 사고, 목 뼈끗 [허리] 기침, 넘어짐, 허리 뼈끗, 걷다가	
L	통증이 있는 부위가 어디인가요?/짚어보시겠어요? 허리/목 외에 아픈 곳은 없나요? → 연관통이나 다른 관절 통증 여부 확인 [방사통] 통증이 어디로 뻗어나요?	
D	[자속 시간] 통증이 얼마나 지속되나요? [빈도] 하루에 몇 번이나 통증을 느끼시나요?	
Co	통증이 점점 더 심해지나요?	
Ex	이전에도 통증이 있었나요?/그때 병원에서 진단을 받으셨나요? 진통제 or 파스를 쓰셨나요?/효과가 있던가요?	
C	[양상] 통증이 어떤 양상인가요?(칼로 찌르듯이/전기가 통하듯이/둔하고 빠근) 압통(T)/발적(R)/종창(S)/열감(H)/움직일 때 소리(C)/움직임 제한(L)이 있나요? [NRS] 안 아픈 것을 0점, 가장 아픈 것을 10점으로 했을 때 몇 점 정도로 아프신가요? 암기법 관절 양상 TRaSH CLaN 설명 통째로 외워줍시다(Tenderness/Redness/Swelling/Hot/Creptitus/LOM/NRS)	
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화(암 전이) [추간판탈출증] 팔이나 손 힘이 약해졌나요? 팔이나 어깨 감각이 둔한 느낌이 있나요? [삼차 신경통] 얼굴에 전기가 통하는 듯한 통증이 있나요? [수막염] 두통/감기 증상/목 뻣뻣한 증상	[전신] 발열/오한/피로/체중 변화(암 전이) [추간판탈출증] 다리 근력 저하/감각 저하 [척추관협착증] 파행(걷다가 다리가 아파서 쉬어야 하나 요?) [마미중후군] 요실금/변실금/항문 주위 감각 이상

	[전방 구조물(중앙)] 목소리 변화/발음 어려움/침 삼킬 때 통증/구역/구토 [근막통증후군] 통증이 있을 때 땀이 나고 털이 곤두서는 증상이 있나요? (자율신경계 Sx) [척추 염좌] 목을 구부리기 어려운가요? 암기법 목이 아파 탈출 시도하는 삼수생 종군	[강직척추염] 조조강직/포도막염/설사/복통 [정신] 우울 [척추 염좌] 허리를 굽히기 어려운가요? 암기법 허리 아파 탈출하는 협객은 맘이 강직하다
F	통증을 악화시키거나 완화시키는 특별한 요인이 있나요? [자세] 특별히 통증이 악화되거나 완화되는 자세가 있나요? (굽힘/젖힘) [운동] 휴식 시 통증이 완화되나요?/아니면 움직이면 완화되나요? (류마티스 질환)	
E	이전 건강 검진에서 이상 소견은 없었나요?	
외	[수술] 목/허리 수술 받으신 적 있으세요? [외상] 목/허리를 다친 적이 있나요?다른 부위가 골절된 적이 있으신가요?	
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/결핵/류마티스 질환/골다공증/암)	
약	현재 복용 중인 약물이 있나요?/진통제를 복용해 보셨나요? 복용 시 통증이 호전되나요?	
사	술, 담배, 커피는 얼마나 하시나요? 운동을 많이 하시는 편인가요?/최근에 격한 운동을 한 적이 있나요? 직업이 어떻게 되시나요?/근무 시 주로 어떤 자세인가요? 스트레스를 많이 받으시나요?	
가	가족 중에 유사한 증상을 가진 분이 계신가요? 가족 중에 류마티스 질환/척추/신경계 질환이 있는 분이 있나요?	
여	폐경	
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] “뒤로 돌아주세요.” 1. 통증 부위 시진/촉진(압통점 여부 확인)* 2. 목 ROM 평가(flexion, extension, lateral bending, rotation)*	[서서] “허리를 보기 위해 상의를 올려주세요.” 1. 통증 부위 시진/촉진(압통 여부, 척추의 만곡 정도 확인)* 2. 허리 ROM 평가(flexion, extension, lateral bending, rotation)*



3. 상지 감각/근력/DTR 평가★

- 감각
- C5 : Deltoid
 - C6 : 엄지
 - C7 : 중지
 - C8 : 새끼 손가락
 - T1 : Medial forearm
- 근력
- C5 : Elbow flex
 - C6 : Wrist ext
 - C7 : Elbow ext
 - C8 : Finger flex
 - T1 : Finger abduction

DTR(Biceps, Triceps)

4. **Spurling's test**★ : 목 hyperextension, lateral flexion 후 위에서 누를 때 팔로 방사통

5. **Lhermitte sign**★ : 목 flexion 시키면 전기 통하듯이 엉덩이까지 통증이 느껴짐

[누워서]

6. 수막 자극 징후

3. 걸음걸이 시진 “저기까지 걸어갔다 오세요.”

4. Schober test : 허리를 폈을 때와 굽혔을 때 늘어나는 거리 측정 (정상 >5cm)

⊕ AS 의심 시 chest expansion test 추가 시행

[침대에 앉아서]

5. **하지 감각/근력/DTR(무릎, 발목) 평가★**

[누워서]

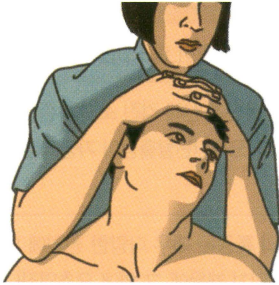
6. **SLR test, Patrick test**★ : 반드시 양측 모두 시행하여 각각 HIVD, AS 감별
7. 말초동맥 맥박 촉진 : 척추관협착증 의심 시 혈관성 파행 배제 목적

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

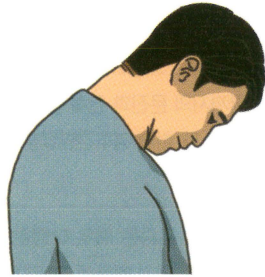
STEP 2 환자 교육

	목 통증(Neck pain)	허리 통증(Low back pain)
공감	목 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.	허리 통증 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 경추간판탈출증이 가장 의심됩니다.	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 요추간판탈출증이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 목 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 경추염좌, 근막통증증후군도 완전히 배제할 수 없습니다.	하지만 허리 통증은 매우 다양한 원인에 의해 발생할 수 있기 때문에 그 외에 요추염좌나 척추관협착증 등도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 경추 X-ray와 CT, MRI 검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?	따라서 정확한 진단을 위해 허리 X-ray, 허리 CT와 MRI가 필요할 것 같습니다. 괜찮으신가요? (AS일 때) 허리 X-ray와 혈액 염증 수치를 확인하겠습니다. 그리고 눈에 염증이 같이 동반되는 경우가 많기 때문에 안과 검진도 같이 예약해 드리겠습니다.
치료	만약 검사로 경추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.	만약 검사로 요추간판탈출증이 확진되면 우선 통증을 조절하기 위해 보조기 착용과 소염진통제 치료가 필요할 것 같습니다. 하지만 이런 치료로도 충분히 통증이 조절되지 않을 땐 수술이 필요할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.	
교육	좋지 않은 자세나 수면 습관 등은 목 통증을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 베개는 낮은 베개로 바꾸시는 게 좋고, 무리한 운동도 피하세요. 하지만 찜질이나 마사지, 스트레칭 등은 목 통증을 완화시켜 줄 수 있습니다.	좋지 않은 자세는 허리 통증을 더욱 심화시킬 수 있습니다. 항상 서 있거나 앉았을 때 바른 자세로 있는 것이 중요합니다. 제가 바른 자세와 허리 통증을 줄이는데 도움이 되는 좋은 운동법이 적힌 안내 책자를 챙겨드리도록 하겠습니다. 꼭 집에서 규칙적으로 따라서 운동해 주세요.
응급	혹시 갑자기 배변, 배뇨장애가 생기거나 팔 힘이 갑자기 빠지거나 움직일 수 없을 정도의 통증이 생긴다면 병원으로 다시 방문해 주세요.	그 사이 갑자기 배변, 배뇨장애가 생기거나 다리 힘이 빠지거나 감각이 저하되거나 걷기 힘들어지면 병원으로 다시 방문해 주세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?	

목 통증(Neck pain)



[스펠링 테스트 (Spurling's test)]



[레르미트 징후 (Lhermitte sign)]

❖ 기본적 진단 계획

- ① Cervical X-ray, Cervical MRI/CT
- ② 근전도검사(EMG)

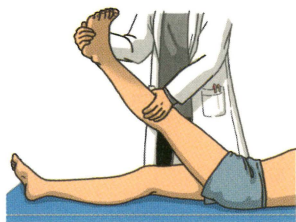
❖ 치료 계획

- ① 찜질 및 물리 치료
- ② 약물 치료 : NSAIDs
- ③ 추간판탈출증 : 수술적 치료
- ④ Myofascial pain syndrome : IMS (Intramuscular stimulation), TPI (Trigger point injection)
- ⑤ 경추염좌 : Neck brace

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 대체로 수술보다는 물리 치료, 진통제 등으로 증상을 완화시키며, 주기적으로 목 스트레칭을 적절히 해 주는 것이 중요하다.
- ② 급격히 다리의 힘이 약해지고 대소변 기능의 장애가 발생하는 등 신경 증상이 악화되는 환자가 아니면 수술은 응급하게 시행하지 않아도 됨★

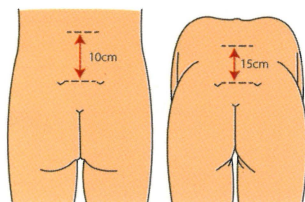
허리 통증(Low back pain)



[하지직거상검사(SLR)]



[패트릭 검사(Patrick test)]



[쇼버 검사(Schober test)]

❖ 기본적 진단 계획

- ① L-spine X-ray (AP, lateral view)/CT, Lumbosacral MRI
- ② 근전도검사(EMG)

❖ 치료 계획

안정, 견인, 소염진통제, 국소주사요법, 수술	
요추염좌	안정, 물리 치료
추간판탈출증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
척추협착증	침상 안정, 물리 치료, 약물 치료, 필요 시 수술
암의 척추 전이	전이암에 대한 고식적 치료(수술, 방사선 치료), 원발암 조절(항암 치료)
마미증후군	응급 수술로 완전히 감압
강직척추염	NSAID, infliximab, sulfasalazine 검사는 ESR, CRP, HLA-B27
요추 압박 골절	수술, 골다공증 치료

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 안정 및 적당한 운동(스트레칭) 필요함을 교육하고 올바른 자세로 활동할 것을 교육
- ② 암 전이 등으로 심한 신경학적 이상 발생 시 응급 조치(방사선 치료, 수술)가 필요함을 교육



keyword

	C	방사	A	F
탈출증	찌르뚫(한쪽)	○	근력, 감각 저하	목 젖힘 통증
염좌	빠근 (뒷목 아래 양측)	×	-	움직이면 악화/ 쉬면 완화
채찍질 손상	빠근	○	교통사고, 두통, N/V, 어지럼	-
근막통증증후군	빠근 (뒤통수 당김)	?	아픈 부위 명확, 땀, 탈섬	-

목 통증

목 통증의 경우 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염, 종양, 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 : 통증의 양상/강도, 수술/약물/골다공증 과거력 확인하기

악화 요인 : 휴식/아침에 악화(류마티스) ↔ 운동 시 악화(경추염좌), 자세 변화(경추간 판탈출증 등)

신체 진찰 : (앉아서) 통증 부위 시진/촉진, 목 ROM 평가, 상지/하지 감각/근력/DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Spurling's, Lhermitte, (누워서) 수막 자극 징후

교육 : 보존적 치료(물리 치료, 보조기 착용, 진통제) → (통증 호전 안 될 시) 수술 근무 환경에서의 자세 교정, 스트레칭/마사지

응급 상황 교육 : 배변/배뇨 이상, 감각/근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원

허리 통증

허리 통증의 경우도 신경학적 이상과 근골격 원인, 기타(감염, 종양, 류마티스 질환)로 나누어 감별하기

병력 청취 : 통증의 양상/강도/다른 부위 통증 + 동반 증상(요실금, 포도막염 등), 과거 치료 여부 및 반응, 수술/약물/직업/운동/골다공증 과거력 확인하기

악화 요인 : 휴식/아침에 악화(강직척추염) ↔ 걸을 때(요추염좌), 자세 변화(요추간판 탈출증, 척추관협착증 등)

신체 진찰 : (앉아서) 상지/하지 감각/근력/DTR(Biceps, Triceps, 무릎, 발목), Schober (엎드려서) 허리 ROM 평가, 시진/촉진, (Supine 누워서) SLR, Patrick

교육 : 보존적 치료(물리 치료, 보조기 착용, 진통제/온찜질) → (통증 호전 안 될 시)수술/근무 환경에서의 자세 교정, 스트레칭, 마사지

응급 상황 교육 : 배변/배뇨 이상, 감각/근력 저하 등 신경학적 이상 발생 시 내원